

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	呼吸道融合病毒 Respiratory Syncytical Virus				
編號	A31000-Q03-W-N28	制定者	R10 陳倩芳	公布日期	113 年 06 月 18 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.1 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解呼吸道融合病毒的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，使護理人員有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部兒科各單位

三、說明

（一）定義

人類呼吸道融合病毒(respiratory syncytical virus, RSV)，為副黏液病毒科肺病毒屬中型單鏈 RNA 病毒，好發於冬天和早春，主要透過飛沫或近距離的接觸傳染，會造成呼吸道感染，具有高度傳染性，可能導致嬰兒罹患細支氣管炎和肺炎等嚴重的肺部感染。

（二）症狀

1. 呼吸道融合病毒的典型症狀與一般感冒相似，包括：初期出現發燒、咳嗽、鼻塞、流鼻水。嬰兒感染後，通常還會出現以下症狀：煩躁不安、食慾下降、活動力減少、呼吸困難、哮喘、甚至併發中耳炎。呼吸道融合病毒一般感染後，須約 2 週時間才會完全痊癒。
2. 呼吸道融合病毒主要的感染對象是 5 歲以下兒童，尤其是 2 歲以下的孩子。呼吸道融合病毒的高危險族群包括：早產兒、患有慢性肺部疾病、先天性心臟病、染色體異常疾病、免疫不全疾病、神經肌肉疾病患童。

（三）常見檢驗檢查

主題名稱	呼吸道融合病毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N28	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/5

1. 嬰幼兒可依其年齡及典型的症狀來診斷是否為 RSV 的感染，另可透過一些方法來鑒定，包括：病毒分離及鑑定(virus isolation)、核酸檢測(PCR)、血清學檢查，或者是抗原檢測(respiratory syncytial virus antigen screening test)。
2. 脈搏血氧感測：檢查血流中的氧氣濃度是否低於正常值。
3. 血液測試：檢查白血球數目或確認是否有病毒、細菌或其他有機體存在。
4. 胸部 X 光：檢查是否罹患肺炎。

(四) 常見治療

1. 支持性療法

照護者請務必注意病童水分補充是否充足，仔細觀察是否有脫水(dehydration)的徵兆，如：口乾、尿量少或無尿、眼睛凹陷、極度煩躁或嗜睡。另外，病童家中若有準備支氣管擴張劑(bronchodilator)與類固醇(corticosteroid)噴劑，可使用改善部分病童下呼吸道阻塞症狀，但不建議常規使用。

2. 住院治療

嚴重呼吸道融合病毒感染時，可能須住院接受輸液治療及使用支氣管擴張劑噴霧治療；若呼吸道症狀加劇可能插管須使用呼吸器，讓呼吸更順暢。

(五) 護理問題

1. 發燒/與呼吸道融合病毒感染有關。
2. 無法有效呼吸/與呼吸道感染、分泌物黏稠、虛弱或年紀小無法咳出痰液有關。
3. 呼吸道清除功能不良/與呼吸道感染、分泌物增加有關。

(六) 護理措施

1. 發燒/與呼吸道融合病毒感染有關

- (1) 密切監測體溫、脈搏、聽診肺部呼吸音變化。
- (2) 說明並讓主要照顧者知悉引起體溫過高之因素，例如：疾病、室內溫度、覆蓋。
- (3) 過多的被蓋或衣物。

主題名稱	呼吸道融合病毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N28	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/5

- (4) 說明並讓主要照顧者知悉，個案發熱前處置，如：寒顫、四肢冰冷時增加被蓋。
 - (5) 寒顫發冷結束後則減少被蓋，維持室內溫度介於 20-24 度，及保持空氣流通。
 - (6) 說明並讓主要照顧者知悉退燒出汗時，協助更換衣物及穿著易吸汗棉質衣物，以保持身體乾爽。
 - (7) 依醫囑協助主要照顧者餵食口服解熱鎮痛藥物。
2. 無法有效呼吸/與呼吸道感染、分泌物黏稠、虛弱或年紀小無法咳出痰液有關。
- (1) 評估個案呼吸型態、速率、血氧飽和濃度、膚色及呼吸音，注意有無呼吸費力徵象，即時依變化處理。
 - (2) 密切觀察生命徵象及臨床呼吸變化。
 - (3) 集中照護，減少不必要刺激，穩定情緒，避免激動造成耗氧量增加。
 - (4) 用枕頭及棉被支撐身體，採半坐臥舒適姿勢，協助呼吸順暢。
 - (5) 讓個案願意接受蒸氣治療，有效吸入藥物可使用吸入輔助器以達到治療效果。
 - (6) 五歲以上幼童，教導其深呼吸及有效咳嗽、採噉嘴式呼吸。
 - (7) 視需要給予氧氣，以減少缺氧情況。
3. 呼吸道清除功能不良/與與呼吸道感染、分泌物增加有關。
- (1) 評估呼吸音，痰的性質跟量。
 - (2) 採半坐臥臥姿，每兩個小時改變姿勢。
 - (3) 依醫囑使用噴霧治療並視病童情況，給予翻身、姿位引流、背部扣擊、震顫等措施。
 - (4) 若病童無法自咳，視情況依醫囑給予抽痰。
 - (5) 評估病童的液體攝取量，必要時由靜脈注射並補充水分。
 - (6) 若呼吸喘，依醫囑給予氧氣。

(七) 實施及修訂

主題名稱	呼吸道融合病毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N28	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/5

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 陳月枝、黃靜微、林元淑、洪兆嘉、張綠怡、蔡綠蓉...魏琦芳(2021)．兒童呼吸系統疾病及其護理·於蔡綠蓉編著，實用兒科護理學(9 版，346-409 頁)·台北：華杏。
- (二) Messina A, Germano C, Avellis V, Tavella E, Dodaro V, Massaro A., Vitale R, Masturzo B, Manzoni P (2022). Manzoni New strategies for the prevention of respiratory syncytial virus(RSV). Early Hum Dev, 174. DOI： 10.1016/j.earlhumdev.2022.105666

七、附件

(略)

